

Un genitore autistico che sostenete

Per doule, assistenti personali, assistenti e aiuti familiari — sostenere un adulto autistico che è (o sta per diventare) genitore.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un genitore si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Fare il genitore è incessante, ad alto canale e imprevedibile — proprio le condizioni che un sistema monotropico trova più difficili — per cui i genitori autistici portano un **alto rischio di burnout** e spesso ignorano i propri bisogni. Come assistente potete essere la presenza calma, prevedibile e pratica che tiene a galla loro e la famiglia: seguite le loro routine, abbassate il carico e state attenti al burnout che sottovaluteranno.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Devoto, eppure in sovraccarico sensoriale e „non ce la fa”	Carico genitoriale su un sistema monotropico — alto rischio di burnout
Salta i pasti, ignora il proprio dolore o l'esaurimento	Differenze di interocezione + iper-focus sul bambino
Anosio, routine rigide attorno al neonato	La prevedibilità riduce il carico — non è „controllo”
Si fa silenzioso o va in shutdown	Sovraccarico/shutdown — serve calma, non pressione
Vuole lo stesso piano, lo stesso aiuto, ogni volta	La coerenza abbassa un carico già altissimo

Provate questo

- **Seguite le loro routine e preferenze** — la coerenza tra le visite abbassa il carico; non disfatte mai del loro sistema „a modo vostro”.
- **Siate prevedibili** — stessa persona, stesso orario, preavviso di ogni cambio; avvisate prima delle visite.
- **Offrite aiuto concreto e specifico** — un pasto, una finestra di sonno, un riordino, una poppata — e proteggete il loro tempo di interesse/recupero.
- **Comunicare alla lettera e per iscritto** dove aiuta; concedete tempo di elaborazione e scelta.
- **State attenti al burnout** e chiedete proattivamente di dolore, esaurimento e alimentazione — lo sottovaluteranno.

Da evitare

- Visite a sorpresa, cambi improvvisi o prendere in mano le loro routine.
- Interpretare il sovraccarico o lo shutdown come „non si lega” o „non ce la fa”.
- Aggiungere richieste sociali o sensoriali a un genitore già svuotato.

Quando chiedere altro supporto

State attenti al **burnout autistico** e alla malattia mentale perinatale (le due si sovrappongono e necessitano entrambe di cure specifiche). Segnalate il **supporto tra pari di genitori autistici** e passate al medico di base/puericultrice se vedete segnali di crisi. Se anche il bambino è neurodivergente, riconoscete il carico cumulativo.

Se il genitore è una madre

Le madri autistiche sono spesso mal-diagnosticate e mascherano intensamente, anche con il personale di supporto. Chiedete delle differenze sociali/sensoriali lifelong, non solo dell'umore attuale.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parti 4 e 7), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parte 3.4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Kelly Mahler (2024). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.